Coagulopatías congénitas y adquiridas en cirugía

De la enfermedad de von Willebrand a la coagulopatía del paciente crítico — reconocer para planificar

Congénitas: vW, hemofilias, raras · Adquiridas: hepática, CID, dilución · Plan perioperatorio · Cuándo derivar a hematología · Principios de tratamiento

> **Ancla de evidencia (referencia vertebral):** Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, et al. *Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders (UKHCDO / British Committee for Standards in Haematology).* Br J Haematol 2014;167(3):304–326. *doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: las coagulopatías congénitas (von Willebrand, hemofilias, déficits raros) exigen planificación con hematología y tratamiento específico; las adquiridas (hepática, CID, dilución, fármacos) se tratan corrigiendo la causa y el déficit dirigido. Reconocer el tipo es lo que cambia el plan.

Una coagulopatía no manejada convierte una cirugía rutinaria en una hemorragia. Conviene distinguir las **congénitas** —conocidas o detectadas en el cribado (PBM-15), que requieren plan específico— de las **adquiridas**, frecuentes en el paciente quirúrgico y crítico.

Este documento, con ancla **REV**, ofrece un mapa práctico de ambas familias y los principios de manejo perioperatorio, remitiendo a PBM-18 para los fármacos hemostáticos concretos y subrayando cuándo es imprescindible la **colaboración con hematología**.

Índice

1. Coagulopatías congénitas
2. Coagulopatías adquiridas
3. Principios de manejo perioperatorio
4. Cuándo derivar y planificar con hematología
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Coagulopatías congénitas

La más frecuente es la **enfermedad de von Willebrand**, a menudo infradiagnosticada y con coagulación básica normal (de ahí el valor del cribado por anamnesis, PBM-15). Le siguen las **hemofilias A y B** (déficit de factor VIII y IX) y los **trastornos raros de la coagulación** (déficits de fibrinógeno, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII), cuyo diagnóstico y manejo requieren factores específicos y guía experta [1]. Todas comparten un principio: **plan perioperatorio anticipado** con objetivos de factor y cobertura definidos por hematología.

PUNTOS CLAVE

- La **von Willebrand** es la coagulopatía congénita más común y suele cursar con TP/TTPa normales [1].
- Las congénitas exigen **plan anticipado**, tratamiento **específico** (factor/desmopresina) y hematología [1].
- Las adquiridas se tratan **corrigiendo la causa** y el déficit dirigido, no con «recetas» fijas.

2. Coagulopatías adquiridas

Son las más frecuentes en el quirófano y la UCI: la **coagulopatía hepática** (síntesis deficiente de factores, con un equilibrio frágil que el TP no refleja bien), la **coagulación intravascular diseminada (CID)**, la **coagulopatía por dilución**

y consumo de la hemorragia masiva (PBM-13), la **coagulopatía traumática** y la inducida por **fármacos** antitrombóticos (PBM-16). El tratamiento se dirige a la **causa** y al déficit demostrado, idealmente guiado por viscoelástica (PBM-09) [2].

3. Principios de manejo perioperatorio

TABLA 1 · PRINCIPIOS DE MANEJO SEGÚN TIPO DE COAGULOPATÍA

Tipo	Principio de manejo
Von Willebrand	Desmopresina (en tipos respondedores) o concentrado de FvW/FVIII; plan con hematología [1].
Hemofilia A/B	Reposición del factor deficitario a objetivos según cirugía; evitar antiagregantes [1].
Déficits raros	Factor específico o plasma según disponibilidad; guía experta [1].
Coagulopatía hepática	Corregir lo corregible; no transfundir plasma por un INR alterado sin sangrado (PBM-02) [2].
CID	Tratar la causa; soporte con componentes según sangrado y parámetros [2].
Dilución / masiva	Protocolo de transfusión masiva, fibrinógeno, calcio, normotermia (PBM-13) [2].

Síntesis de la guía de trastornos raros [1] y de la guía ESAIC [2]. La corrección se dirige a la causa y al déficit demostrado.

4. Cuándo derivar y planificar con hematología

Toda **coagulopatía congénita conocida o sospechada** (cribado positivo, historia familiar) debe planificarse **con antelación** junto a hematología: definir objetivos de factor, profilaxis, disponibilidad de concentrados y plan de rescate. En las adquiridas, la colaboración es útil ante CID, hepatopatía avanzada o hemorragia que no responde. La regla de oro es **anticipar**: el peor momento para descubrir una coagulopatía es durante la hemorragia [1,2].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): distinguir coagulopatía congénita de adquirida cambia el plan: las congénitas exigen anticipación, tratamiento específico y hematología; las adquiridas, corregir la causa y el déficit dirigido (mejor guiado por viscoelástica). No tratar «números» sin sangrado.

Conecta con **PBM-15** (cribado), **PBM-09** (viscoelástica), **PBM-13** (coagulopatía de la hemorragia masiva) y **PBM-18** (fármacos hemostáticos específicos).

RESUMEN EN UNA FRASE

Reconoce el tipo: congénita → plan anticipado con hematología y factor específico; adquirida → corrige la causa y el déficit demostrado —sin transfundir por una analítica sin sangrado—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **REV** apoyado en la guía de trastornos raros de la coagulación [1], la guía ESAIC [2] y la guía BSH de plasma/crioprecipitado [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los principios de manejo (plan anticipado en congénitas, corrección dirigida en adquiridas, no transfundir plasma por INR sin sangrado) proceden de estas fuentes.

7. Referencias

1. Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, Bowles L, Chowdary P, Grainger J, et al. Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders: a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organization guideline on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2014;167(3):304–326. doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-17 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*